

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA

Centro Materno-Infantil (sintético) — Consultorio de Alto Riesgo Obstétrico

FILIACIÓN

Nombre:	PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad:	38 años
Estado civil:	Casada
Ocupación:	Independiente
Fecha de elaboración:	05/04/2026

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G4 P3 (3 partos vaginales previos: 2014, 2017 y 2020). Recién nacido del último embarazo: 4,100 g (macrosómico). Antecedente familiar: madre con diabetes tipo 2.

GESTACIÓN ACTUAL

FUM:	20/09/2025
FPP:	27/06/2026
EG actual (por FUM):	28 semanas
Controles prenatales:	6 al momento
Diagnóstico nuevo:	Diabetes gestacional

Paciente sin síntomas clásicos de hiperglucemia (polidipsia, poliuria, polifagia). Tamizaje universal de DG indicado por edad materna avanzada y antecedente de macrosomía.

CURVA DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA (75 g)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Glucosa ayuno	105	mg/dL	Sobre umbral DG (≥ 92)
Glucosa 1 h	195	mg/dL	Sobre umbral DG (≥ 180)
Glucosa 2 h	165	mg/dL	Sobre umbral DG (≥ 153)

OTROS LABORATORIOS (28/03/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
HbA1c	6.4	%	Compatible con DG
Hemoglobina	12.1	g/dL	Dentro de rango
Creatinina	0.7	mg/dL	Normal
TSH	2.0	mUI/L	Dentro de rango
Urocultivo	Negativo	—	Sin ITU

ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA (28 SEMANAS)

Feto único, vivo, presentación cefálica. Peso fetal estimado: 1,850 g (percentil 90 — macrosomía fetal estimada). Líquido amniótico aumentado (ILA 22 cm — polihidramnios leve). Doppler arteria umbilical normal. Anatomía sin malformaciones.

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

PA 124/78 mmHg. FC 80 lpm. T° 36.6°C. Peso 82.5 kg. Talla 1.60 m. AU 31 cm. LCF 142 lpm. Edema MMII (-/-).

PLAN

1. Plan nutricional con conteo de carbohidratos por nutricionista. 2. Automonitoreo glucémico capilar: ayuno y postprandial 1 h, 4 mediciones diarias. 3. Interconsulta con endocrinología para considerar inicio de insulina si metas no se logran en 1-2 semanas. 4. Eco obstétrica + Doppler cada 4 semanas para vigilar crecimiento. 5. Educación sobre signos de hipoglucemia e hiperglucemia. 6. Reevaluar vía de parto cerca del término según peso fetal estimado.

Documento generado para fines de prueba del clinical-extractor de SICA. Sintético. No representa una paciente real.